

ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ & ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ & ΑΥΧΕΝΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ

Το τραυματικό εξάρθρωμα του ισχίου αποτελεί βλάβη υψηλής ενέργειας και επείγον ορθοπαιδικό περιστατικό. Η φυσική άρθρωση του ισχίου είναι εξαιρετικά σταθερή λόγω της γεωμετρίας της σφαιροκοτυλιαίας διάταξης, του επιχείλιου χόνδρου, της ισχυρής κάψας και των περιαρθρικών συνδέσμων και μυών. Για να προκληθεί εξάρθρωση φυσικού ισχίου απαιτείται συνήθως βίαιος μηχανισμός, κατά κανόνα τροχαίο υψηλής ενέργειας ή πτώση από ύψος. Ως εκ τούτου, το εξάρθρωμα του ισχίου ουδέποτε πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένο ορθοπαιδικό εύρημα, αλλά ως **οδηγός κάκωση ενός σοβαρού τραύματος**, με συχνή συνύπαρξη καταγμάτων της κοτύλης, καθώς και της μηριαίας κεφαλής ή του αυχένα, σοβαρών κακώσεων γόνατος (*οστικές και συνδεσμικές*), νευρικών βλαβών και, σπανιότερα, τραυματισμού της θωρακικής αορτής (*συνυπάρχει περίπου στο 8% των εξαρθρωμάτων*) σε περιπτώσεις σοβαρών τραυματισμών με μηχανισμό απότομης (βίαιης) επιβράδυνσης.

Τα οπίσθια εξαρθρώματα ισχίου είναι πολύ πιο συχνά (85-90%) από τα πρόσθια εξαρθρώματα. Το κλασικό πρότυπο είναι το dashboard injury: κάμψη ισχίου, προσαγωγή, έσω στροφή και αξονική φόρτιση μέσω του μηριαίου, με αποτέλεσμα οπίσθια μετατόπιση της μηριαίας κεφαλής. Κλινικά, το σκέλος είναι βραχυμένο, σε κάμψη, προσαγωγή και έσω στροφή. Τα σπανιότερα πρόσθια εξαρθρώματα προκαλούνται από βίαιη απαγωγή με έξω στροφή, με ή χωρίς έκταση ή κάμψη. Στις ανώτερες πρόσθιες μορφές εξαρθρωμάτων το σκέλος εμφανίζεται συνήθως σε απαγωγή, έξω στροφή και συχνότερα σε έκταση, ενώ στις κατώτερες πρόσθιες μορφές βρίσκεται σε μεγαλύτερη κάμψη.

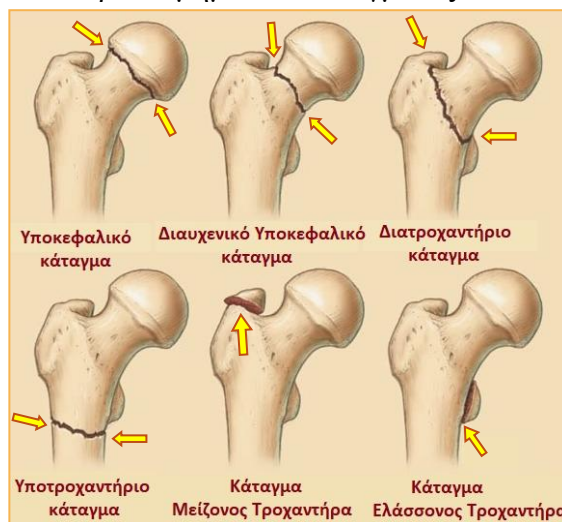
Η ανατομική και λειτουργική σημασία αυτών των τραυματισμών εδράζεται κυρίως σε δύο βασικά στοιχεία: την αγγείωση της μηριαίας κεφαλής και τη γειτνίαση με σημαντικές νευροαγγειακές δομές. Κάθε παρατεταμένη παραμονή της κεφαλής εκτός κοτύλης αυξάνει τον κίνδυνο διαταραχής της αιμάτωσης και, τελικώς, άσηπτης νέκρωσης. Στα οπίσθια, αν και ο τραυματισμός του μηριαίου νεύρου ή των μηριαίων αγγείων είναι σπανιότερος από την κάκωση του ισχιακού νεύρου, όταν συμβεί ενίοτε είναι σοβαρός και υποεκτιμάται.

Τα κατάγματα της κεφαλής του μηριαίου συνήθως συνοδεύονται από εξάρθρωμα του ισχίου. Απεικονίζονται ως οδοντικά κατάγματα του ανώτερου τμήματος της κεφαλής σε συνδυασμό με οπίσθιο εξάρθρωμα. Συντριπτικά κατάγματα συνήθως συμβαίνουν μετά από σοβαρούς τραυματισμούς της πύελου (*πτώση εξ ύψους*). Είναι πιθανό να συνοδεύονται από κάταγμα του αυχένα του μηριαίου ή κάταγμα της κοτύλης (βλ. *ταξινόμηση κατά Pipkin*).

Τα κατάγματα του αυχένα του μηριαίου είναι σχεδόν πάντοτε υποκεφαλικά (σπανίως βασεοαυχενικά). Η γραμμή του κατάγματος αρχίζει συνήθως από το άνω όριο αυχένα - κεφαλής και φέρεται λοξά προς τα κάτω και έξω στο κάτω χείλος του αυχένα αφήνοντας μια τριγωνική οστική περιοχή από τον αυχένα στο κεντρικό τμήμα του κατάγματος.

Κλινικά, κάθε ασθενής άνω των 60 ετών που παραπονείται ύστερα από μια πτώση, για πόνο στην περιοχή του ισχίου, πρέπει να θεωρείται ότι υπέστη κάταγμα του αυχένα του μηριαίου οστού ή διατροχαντήριο, εκτός βέβαια εάν ο απεικονιστικός έλεγχος αποδείξει το αντίθετο.

Τα διατροχαντήρια κατάγματα είναι πιο συχνά σε ηλικιωμένα άτομα πιο προχωρημένης ηλικίας από ότι εκείνα στα οποία συμβαίνουν τα κατάγματα του αυχένα του μηριαίου. Είναι εξωαρθρικά κατάγματα και δεν παρουσιάζουν ισχαιμική νέκρωση της κεφαλής του μηριαίου. Προκαλούνται με τον ίδιο - όπως του αυχένος - μηχανισμό και συχνά χωρίς σοβαρή κάκωση.



Η πρόγνωσή τους είναι καλύτερη από τα κατάγματα του αυχένα, όσον αφορά την πώρωση, αλλά χειρότερη όσον αφορά την επιβίωση. Το τελευταίο οφείλεται αφ' ενός στο γεγονός ότι ένα διατροχαντήριο κάταγμα συνοδεύεται από πιο εκτεταμένη ρήξη μαλακών μορίων που προκαλεί μεγαλύτερη αιμορραγία και αφ' ετέρου στο ότι τα άτομα στην κατηγορία αυτή είναι περισσότερο ηλικιωμένα, συχνά με μεγαλύτερη συννοσηρότητα και πολυφαρμακία.

Χαρακτηριστικά, κλινικά, διαγνωστικά σημεία του κατάγματος αποτελούν, ο έντονος πόνος στην περιοχή του ισχίου, η κατάργηση της κινητικότητας του άκρου, η βράχυνση και η εξωτερική στροφή του τραυματισμένου σκέλους. Η ακριβής διάγνωση και το μέγεθος της κάκωσης, επιβεβαιώνεται απεικονιστικά και καθορίζεται η περαιτέρω αντιμετώπιση.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Όπως αναφέρθηκε τα εξαρθήματα ισχίου είναι κακώσεις υψηλής ενέργειας και πιθανώς υποκρύπτουν και άλλες συνοδές κακώσεις αναλόγως της φύσης του τραυματισμού. Από την άλλη τα κατάγματα κεφαλής/αυχένος μηριαίου συμβαίνουν συχνά σε ηλικιωμένους και μπορεί να αποτελούν το ένα και μοναδικό εύρημα χωρίς αυτό να μας εφησυχάζει!
2. Ελέγχουμε κι εξασφαλίζουμε τη βατότητα του αεραγωγού στο πλαίσιο των A-B-C-D-E. Ελέγχουμε ζωτικά σημεία (*BP, HR, RR, SpO₂, T °C*), την GCS και θέτουμε monitoring.
3. Εκτελούμε ΗΚΓ και διενεργούμε εργαστηριακό έλεγχο (γεν. αίματος, *Glu, Urea, Creat., AST/ALT, K⁺, Na⁺, Ca⁺⁺, ALP, LDH, CPK, CRP*), αντιμετωπίζοντας αναλόγως την όποια συννοσηρότητα (π.χ. *ΑΥ, αρρυθμία, συγκοπή, ΑΕΕ, υπογλυκαιμία, θλαστικό τραύμα, κ.ά.*), η οποία πιθανώς να ευθύνεται για τον τραυματισμό ή επήλθε ως απόρροια της κάκωσης. Είναι αρκετά συχνό - ιδίως σε ηλικιωμένους - κατάγματα μηριαίου να προκαλούνται από οξείες, σοβαρές παθολογικές καταστάσεις, που δεν πρέπει να διαλάθουν της προσοχής.
4. Εξασφαλίζουμε φλεβική πρόσβαση και χορηγούμε ορό 500-1000 ml NaCl 0,9% (~ ΑΠ).
5. Χορηγούνται **αναλγητικά** και **μυοχαλαρωτικά**, ήτοι: 1 fl. 100 ml Apotel 1 gr (iv), καθώς και 1 amp. Vialax 50 mg ή Dynastat 40 mg (iv) και 1 amp. Norflex ή Musco-Ril (im). Εναλλακτικά, χορηγείται 1 fl. *Combogesic* (1 g/300 mg), σε έγχυση εντός 10-15 λεπτών.
6. Επί αφόρητου πόνου, χορηγείται 1 amp. Μορφίνη (ή Tramadol ή Zideron) (iv ή im).
7. Σε επιπεπλεγμένο κάταγμα μηριαίου, ανοσοποιούμε με 1 amp. Tetagam-P 250 iu (im).
8. Ελέγχουμε για άλλες κακώσεις και ψηλαφούμε σφυγμό στο άκρο πόδι (*ιγννακή, ραχιαία και οπίσθια κνημιαία*). Αν υπάρχει δυνατότητα ελέγχουμε με φορητή συσκευή Doppler.
9. Η θεραπεία, αρχικά, πρέπει να επικεντρώνεται στην ανάταξη του πιθανού εξαρθήματος εφόσον έχει αυτό αξιολογηθεί και δεν συνοδεύεται από κάταγμα και στη διάγνωση και ταξινόμηση πιθανού κατάγματος του μηριαίου, με βάση και τα ακτινολογικά ευρήματα.

Χειρισμός Captain Morgan: Ο ασθενής τοποθετείται ύπτια, με το ισχίο και το γόνατο του πάσχοντος σκέλους σε κάμψη.

Ο ιατρός τοποθετεί το γόνατό του κάτω από το γόνατο του ασθενούς, χρησιμοποιώντας τον μηρό του ως υπομόχλιο. Με το ένα χέρι συγκρατεί τον αστράγαλο και με το άλλο χέρι υποστηρίζει το γόνατο, ασκώντας σταδιακή ανοδική έλξη κατά μήκος του μηριαίου (βλ. *εικόνα*). Ταυτόχρονα, εφαρμόζονται ήπιες στροφικές διορθώσεις, έως ότου η κεφαλή του μηριαίου επανέλθει στην κοτύλη. Η τεχνική προσφέρει καλή μηχανική μόχλευση και είναι χρήσιμη στα οπίσθια εξαρθήματα ισχίου.



10. Διακομίζουμε τον τραυματία (*συνοδεία ιατρού*) στο νοσοκομείο, υπό συνεχές monitoring (*ECG, HR, BP, RR, SpO₂*), ειδικά σε περιπτώσεις πολυτραύματος με συνοδές κακώσεις. Εδώ, πρέπει να τονιστεί ότι ο χρόνος μέχρι την ανάταξη του εξαρθήματος αποτελεί τον σημαντικότερο προγνωστικό παράγοντα. Παρότι η βιβλιογραφία δεν είναι απολύτως ομοιογενής ως προς το ακριβές χρονικό περιθώριο, η πρακτική αρχή υποστηρίζει η ανάταξη να γίνει όσο το δυνατόν νωρίτερα, ιδανικά εντός 6 ωρών από την κάκωση.